



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : هبة مصطفى محمد سعد
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : المعادي
رقم البطاقة : 28012030103126 رقم التليفون : 01210042551
العنوان : المعادي
العمر (تاريخ الميلاد) : 03-12-1980 المهنة : حاصل علي دبلوم
تاريخ تسجيل الإستمارة : 01-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة
قسم العلاج :
الأورام [11129]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هبة مصطفى محمد سعد National ID: 28012030103126	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

هبة
مصطفى محمد سيد
اش عبده طه طه الاست
طره - القاهرة

٢٨٠١٢٠٣٠١٠٣١٢٦

LK6028214

٢٠٢٥/١٠ ٢٨٠١٢٠٣٠١٠٣١٢٦
حامله على موبيل في صناعي
اش مصطفى محمد السيد
البيانات سارية حتى ٢٠٢٥/١٠/٠٧

١

Patient Name : الأمينة / هبة مصطفى محمد سعد
Patient No. : 28012030103126
Path No. : SR-937/22
Sex : Female
Age : 42 Y
Referring Doc. :

Request No. : 13003790
Request Date : 04/12/2022
Verification Date : 27/12/2022
Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast cancer .
Nature of the specimen: Slide revision
Gross Examination:
5 Block + 7 Slides

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma with micropapillary features
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Angiolymphovascular invasion: Positive lymphovascular emboli
- Ductal carcinoma in situ: No
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Positive metastatic deposits in 14 LNs with extracapsular invasion (14/16).
- IHC (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (Allred score 8/8)
 - PR: Moderate nuclear reaction in 30% of tumor cells (Allred score 5/8)
 - HER2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)
 - Ki67: 35% nuclear reaction of tumor cells

Diagnosis:

Left breast cancer, Slide revision:

- Invasive duct carcinoma grade II with micropapillary features.
- Free nipple and areola.
- Positive lymphovascular emboli.
- Positive metastatic deposits in 14 LNs with extracapsular invasion (14/16).
- IHC:
 - ER: Positive (score 8/8).
 - PR: Positive (score 5/8).

Verified by :

Dr. Marwa mahmoud

Printing Date : 27/12/2022 10:51:25

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed yousse

Name: هبه مصطفى محمد سعد		
MR. : 3908		
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient was diagnosed with left-breast invasive ductal carcinoma, grade II, with micropapillary features (T2 N3 M0). Pathology demonstrated positive estrogen and progesterone receptors, positive lymphovascular emboli, and involvement of 14 of 16 examined lymph nodes with extracapsular extension. The patient underwent left modified radical mastectomy in October 2022. Adjuvant therapy consisted of four cycles of AC (doxorubicin and cyclophosphamide) followed by 12 weeks of taxol combined with Herceptin and Perjeta, and hormonal therapy with Zoladex; subsequently, the patient was placed on Arimidex with supportive care. To date, the patient has completed four cycles of AC and twelve weeks of taxol. The patient continues on Arimidex and Zoladex with supportive measures, and the next follow-up is scheduled for 28 October 2026.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر	
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		

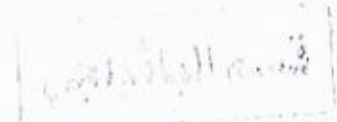
Patient Name	الأستاذة / حبه مصطفى محمد سعد	Request No.	13003790
Patient No.	28012030103126	Request Date	04/12/2022
Path No.	SR-937/22	Verification Date	27/12/2022
Sex	Female	Financial Category	أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	42 Y	Department	Out Patient
Referring Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- HER2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 35% of tumor cells.

Dr. Israa Elgendy

Prof. Dr. Manal Elmahdy



Verified by :

Dr. Marwa mahmoud

Printing Date : 27/12/2022 10:51:25

Page 2 of 2

Printed By : .marwa mohamed yousse



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Wellness

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



A-Patient ID:

1- Name: *فايزة مصطفى محمد*

Sex:

3- Medical numbers
Female

63106104

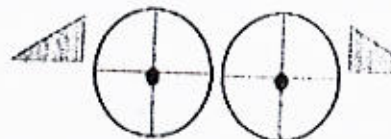
Old Med:

4631-2022

2-ID number: 28012030103125

Patient Age: 42 Y

MDT



Family history

-VE

Phone

SHI

REASON OF MDT

remdt

marital status

ARS Score

GROUP

Date of MDT

01/03/2023

Comorbidity

2

marital status

Menopausal status

Clinical data

Breast Imaging:

Mets Workup:
CYCAP-->FREE

BX:

LT ILC GII WITH
MICROPAPILLARY
FEATURES 12/22

IHC:

ER:
8/8

PR:
8/8

Her 2 Neu:
+ve

KI67:
35%

T
T2

N
3

M
0

Sonotamniography

Recommendations:

LT HRM DONE 10/2022 OUTSIDE

LT BREAST CA WITH IDC GII WITH MICROPAPILLARY FEATURES
FREE NIPPLE AND AREOL

+VE LYMPHOVASCULAR EMBOLI

+VE METS DEPOSITS IN 14 LNS WITH EXTRA CAPSULAR INVASION 14/16

MDT OUTCOME & PLAN

for AC X 4 cycles and 12 weeks of taxol with Herceptin and Prejeta
hormonal treatment (AI+Zoladex)

FOTRY

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	<i>Shiraz Khan</i>	RADIOLOGY	
SURGERY	<i>Arzoo Shah</i>	PATHOLOGY	<i>Ram Ahmed</i>
Psychiatric		Nutrition	

about date



Exam : C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age : 42 Year(s)
Medical ID:	

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

1. Chest:

- Left MRM with no enhancing masses or localized collection.
- Bilateral scattered tiny pulmonary nodules, the largest is noted at anterior segment of left upper lung lobe measuring 4 mm.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. The scanned skeleton:

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.